	AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA PACIENTE INTERNADO	**FOR.RPA.0010/00 Implantação: 09/2024 Classificação: INTERNO PEP**

HISTÓRICO MÉDICO	*(PUXAR AUTOMÁTICO DO HISTÓRICO DE SAÚDE)*
HABITOS DE SAÚDE	*(PUXAR AUTOMÁTICO DO HISTÓRICO DE SAÚDE)*
AVALIAÇÃO FISICA	PESO:_____ ALTURA:_____IMC:_____*[PUXAR AUTOMÁTICO DOS SSVV]*
SINAIS VITAIS	*(PUXAR AUTOMÁTICO DO ULTIMO REGISTRO)*
ALERGIAS	*(PUXAR AUTOMÁTICO DA ABA DE ALERGIAS)*
TIPO DE CIRURGIA PROPOSTA	*CAMPO TEXTO*
PORTE CIRURGICO	*CAMPO TEXTO*
DATA E HORÁRIO DO PROCEDIMENTO	*CAMPO TEXTO*
MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR	*(PUXAR LISTA DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA CLÍNICA)*
ANESTESIAS ANTERIORES	( ) NÃO ( ) SIM
	CAMPO TEXTO
	( )Complicações anestésicas passadas [abrir lista]
LISTA DE COMPLICAÇÕES PASSADA	[LISTA POSSIBILIDADE DE SELECIONAR MAIS QUE UMA DAS OPÇÕES] [+] • Reação Alérgica (Anafilaxia) • Hipotensão (Pressão Arterial Baixa) • Náusea e Vômito Pós-Operatório (NVPO) • Dor de Garganta • Hipotermia (Baixa Temperatura Corporal) • Confusão e Delirium Pós-Operatório • Lesão Dentária • Tremores e Arrepios • Retenção Urinária • Dor no Local da Injeção • Paralisia Temporária ou Prolongada • Aspiração Pulmonar • Bloqueio Nervoso Incompleto ou Falha da Anestesia • Complicações Cardiovasculares • Edema Pulmonar • Hipertermia Maligna Outras:_____ [/LISTA]
POSSIBILIDADE DE GRAVIDEZ	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA
DENTIÇÃO	Alteração dentaria? ( ) Não ( ) Sim:_____
OUTROS DISPOSITIVO	Outros: _____
RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS	Puxar automático dos últimos resultados de exames Hemoglobina Hematócrito Leucócitos Plaquetas Glicemia de Jejum Creatinina Ureia Enzimas hepáticas Coagulograma TP TTPA INR
EXAMES COMPLEMENTARES	Eletrocardiograma (ECG) Exames de Urina Raio X

RESERVA DE HEMOCOMPONENTES	**( )Não se aplica** **( )SIM [abrir resultados exames]** **Tipo** **Sanguíneo** **Prova** **Cruzada**
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	CLASSIFICAÇÃO ASA: *[LISTA]* ASA I: Recuperação em SRPA padrão. ASA II: Recuperação em SRPA padrão com possível monitoramento adicional. ASA III: Recuperação em SRPA, SEMI ou UTI dependendo da estabilidade. ASA IV: Recuperação em UTI. ASA V: Recuperação em UTI. ASA VI: PROTOCOLO ME ASA E: Recuperação em SRPA padrão ou UTI, dependendo da emergência e da condição do paciente. *[/LISTA]* EXAME FÍSICO: ( ) NORMAL ( ) ALTERADO *(campo para descrever)*
	BRONCOASPIRAÇÃO: ( ) BAIXO RISCO ( ) RISCO MODERADO ( )ALTO RISCO
	NÁUSEAS/VÔMITOS: ( ) BAIXO RISCO ( ) RISCO MODERADO ( )ALTO RISCO
	RISCO DE TEV: PUXAR AUTOMATICO DO SCORE AVALIADO [ATUALIZAR]
	CEFALEIA PÓS PUNÇÃO ( ) BAIXO RISCO ( ) RISCO MODERADO ( )ALTO RISCO ( ) NÃO SE APLICA
	HIPOTERMIA INTRAOPERATÓRIA ( ) BAIXO RISCO ( ) RISCO MODERADO ( )ALTO RISCO
	HIPERTERMIA INTRAOPERATORIA ( ) BAIXO RISCO ( ) RISCO MODERADO ( )ALTO RISCO
	LESÃO DE POR POSICIONAMENTO: PUXAR RESULTADO ESCALA DE ELPO
	SANGRAMENTO INTRA-OPERATÓRIO ( ) BAIXO RISCO ( ) RISCO MODERADO ( )ALTO RISCO
TECNICA ANESTESIACA PROPOSTA	**Anestesia Regional** 1. Bloqueios periféricos 2. Bloqueio Peridural (Epidural) 3. Bloqueio Raquidiano (Espinhal)
	Anestesia Local 1. Infiltração Local 2. Bloqueio de Campo 3. Anestesia Tópica
	Sedação Consciente ou inconsciente 1. Sedação Moderada 2. Sedação Profunda
MANEJO DE VIA AÉREA	Escala de Mallampati: *[LISTA]* Class e I Class e II Classe III (Abri lista de achados preditivos para VAD) Classe IV (Abri lista de achados preditivos para VAD) Material especial para VAD? ( )Não ( )Sim [abre lista] [ABRIR LISTA DE ACHADOS PREDITIVOS DE VAD e DISPOSITIVOS AVANÇADOS NECESSARIOS PARA INTUBAÇÃO]
ACHADOS PREDITIVOS DE VAD	Multipla marcação ( ) História prévia de via aérea difícil ( ) Abertura bucal limitada (menos de 3 cm)

	( ) Moilidade atlanto-oociptal limítrofe ( ) Micrognatia (mandíbula pequena) ( ) Macroglossia (língua grande)
DISPOSITIVOS AVANÇADOS NECESSARIOS PARA INTUBAÇÃO	1. Videolaringoscópio 2. Fibrobroncoscópio 3. Máscara Laríngea 4. Combitubo Esofágico-Traqueal (ETC) 5. Bougies 6. Estilete de Intubação com luz 7. Videobroncoscópio Rígido 8. Videobroncoscópio articulado 9. kit cricotireoidostomia 10. Tubo Nasotraqueal 11. Intubação Retrógrada (técnica)

	( ) Dentes proeminentes ou salientes ( ) Dentes frouxos ou ausentes ( ) Distância tireomentoniana reduzida (menos de 6 cm) ( ) Limitação na mobilidade do pescoço ( ) Circunferência do pescoço maior que 40 cm ( ) Anomalias congênitas da face ou pescoço ( ) Presença de massas ou tumores no pescoço ( ) Cicatrizes ou contraturas no pescoço ( ) Trauma facial ou cervical recente ( )Obesidade mórbida (IMC > 40) ( ) Apneia obstrutiva do sono ( ) Deformidades anatômicas adquiridas (ex.: após radioterapia ou cirurgia no pescoço) ( ) Uso de próteses dentárias fixas ou removíveis
JEJUM	*[LISTA]* 1. Líquidos claros sem resíduos (água e chá): 2 horas 2. Leite materno: 4 horas 3. Leite não-humano ou formula: 6 horas 4. Refeições leves: 6 horas 5. Dieta geral: 8 horas *[/LISTA]* Jejum prolongado? ( )Não ( ) Sim[abre campo de abreviação do jejum]
PROTOCOLO DE JEJUM PROLONGADO	Abreviação de Jejum? **( ) SIM** [abre lista] *[LISTA]* • **Fresubin Jucy 200ml:** [abre a lista opção de marcar mais de uma opção] 3 horas antes do procedimento 6 horas antes do procedimento ou • **Carbo CH 200ml** • [abre a lista opção de marcar mais de uma opção] 3 horas antes do procedimento 6 horas antes do procedimento *[/LISTA]* 1°___:_____2°:_____:_____ **( )NÃO** [abre lista de Critérios de exclusão do protocolo] Critérios de exclusão do protocolo: *[LISTA]* • Obesidade mórbida • Gestante • Diabetes mellitus descompensada e/ou insulino dependente • Doença do refluxo gastresofágico sintomático • Cirurgias abdominais de urgência/emergência (abdômen agudo) • Obstrução intestinal, sub oclusão intestinal, regurgitação.

	• Hemorragia digestiva; • Paralisia cerebral • Choque séptico • Trauma (discutir o caso) • Endoscopia digestiva alta • Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) • Ecotransesofágico • Fibrobroncoscopia • Paciente em uso de Liraglutida, semaglutida [/LISTA]
RELATÓRIO DE PASSAGEM DE PLANTÃO PARA EQUIPE CIRÚRGICA	
LOCAL DE RECUPERAÇÃO	Recuperação em SRPA padrão. Recuperação em UTI.
JUSTIFICATIVA	*Campo texto*
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O INTRAOPERATÓRIO E OBSERVAÇÕES	*CAMPO TEXTO*
ANESTESIOLOGISTA RESPONSÁVEL	*ASSINATURA ELETRÔNICA*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

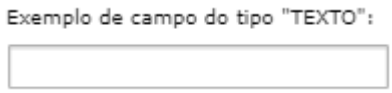
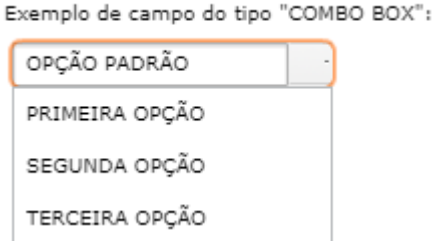
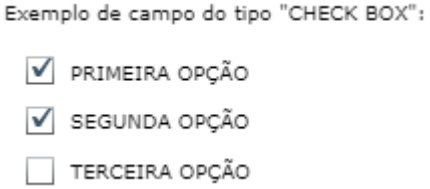
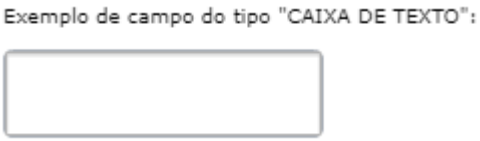
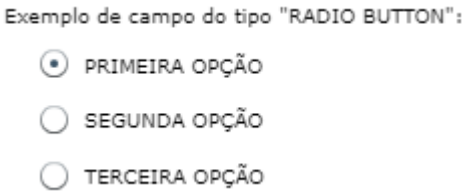
As informações técnicas têm como objetivo esclarecer as diretrizes técnicas para a construção do documento eletrônico, incluindo a especificação de campos, a localização das informações e quaisquer questionamentos identificados na análise inicial realizada pela equipe de TI.

Questionamentos técnicos:

1. **Definição do Aviso Cirúrgico**: O documento não apresenta de forma clara qual é o Aviso Cirúrgico que deve ser usado. Essa falta de definição impede o preenchimento automático de vários campos e compromete o funcionamento correto dos processos que dependem dessa informação.

2. **Diferenças entre Relatório e Documento Eletrônico**: O conceito de um documento eletrônico envolve a interação entre o usuário (médico, enfermeiro ou técnico) e o sistema, permitindo a inserção de dados. No documento atual, porém, dos 40 campos existentes, 19 são apenas para consulta de informações que já estão disponíveis em outro lugar. Ou seja, metade do documento é usada apenas para exibir informações, sem necessidade de interação. A recomendação técnica, nesse caso, é que as informações consultivas sejam reunidas em um relatório separado, mantendo no documento eletrônico apenas os campos onde o usuário realmente precisa inserir dados.

Legenda de campos:

Texto  	Indicado para frases curtas.
Combobox  	Permite selecionar um valor dentre uma lista de valores possíveis, que pode ser uma lista fixa ou uma lista dinâmica.
Checkbox  	Permite a seleção de várias opções simultaneamente.
Caixa de texto  	Campo para inserção de textos maiores.
Radio button  	Permite a seleção de apenas uma opção dentre as exibidas.

Campos	Obrigatoriedade do campo na finalização do documento	Tipo do campo	Detalhamento
HISTÓRICO MÉDICO	SIM	Caixa de texto	**No PEP rotina enfermeiro > UI > Histórico - ADULTO OU PEDIATRICO> Puxar apenas os campos preenchidos das comorbidades: TODAS** **OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO**
HABITOS DE SAÚDE	SIM	Caixa de texto	O profissional irá preencher o campo
AVALIAÇÃO FISICA	**SIM**	**Caixa de Texto**	**No PEP rotina enfermeiro > Centro Cirúrgico > CSV > MEDIDAS. PESO ALTURA E FORMULAS IMC**
SINAIS VITAIS	**SIM**	**Caixa de Texto**	**No PEP rotina enfermeiro > Centro Cirúrgico > CSV > PUXAR O ULTIMO REGISTRO DE SINAIS VITAIS VERIFICADOS**
ALERGIAS	**SIM**	**Caixa de Texto**	**No PEP rotina Téc. Enfermagem > Alergias: puxar todas as cadastradas.** **OBS: O CAMPO PODE SER EDITADO**
TIPO DE CIRURGIA PROPOSTA	SIM	Caixa de texto	O profissional irá preencher o campo
PORTE CIRURGICO	SIM	Caixa de texto	O profissional irá preencher o campo
DATA E HORÁRIO DO PROCEDIMENTO	SIM	Caixa de texto	O profissional irá preencher o campo
MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR	SIM	Caixa de texto	**No PEP rotina farmacêutica>farmácia clínica> RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA - MEDICAMENTOS DO PACIENTE (USO DOMICILIAR):**
ANESTESIAS ANTERIORES	SIM	Combobox/Caixa de texto SE A OPÇÃO FOR SIM	O profissional irá preencher o campo
Complicações anestésicas passadas	NÃO	Checkbox	O profissional irá preencher o campo
LISTA DE COMPLICAÇÕES PASSADA	NÃO	Combobox/POSSIBILIDADE DE SELECIONAR MAIS QUE UMA DAS OPÇÕES] [+]	o campo esta vinculado a marcação da opção Complicações anestésicas passadas

POSSIBILIDADE DE GRAVIDEZ	SIM	Checkbox	O profissional irá preencher o campo
DENTIÇÃO	SIM	Checkbox/CAMPO TEXTO SE A OPÇÃO FOR SIM	O profissional irá preencher o campo
OUTROS DISPOSITIVO	NÃO	**Caixa de Texto**	O profissional irá preencher o campo
RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS	NÃO	Combobox	**No PEP >RESULTADO DE EXAMES>PUXAR AS INFORMAÇÕES DOS ULTIMOS RESULTADOS DISPONIVEIS CASO NÃO POSSUIR O CAMPO DEVER APARECER EM BRANCO E EDITAVEL**
EXAMES COMPLEMENTARES	NÃO	Checkbox /POSSIBILIDADE DE SELECIONAR MAIS QUE UMA DAS OPÇÕES] [+]	O profissional irá preencher o campo
RESERVA DE HEMOCOMPONENTES	SIM	Checkbox/CAMPO TEXTO SE A OPÇÃO FOR SIM	O profissional irá preencher o campo
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	SIM	Combobox para classificação do ASA e Checkbox para os demais	O profissional irá preencher o campo
TECNICA ANESTESIACA PROPOSTA	SIM	Combobox	O profissional irá preencher o campo
MANEJO DE VIA AÉREA	SIM	Combobox e Checkbox para Material especial para VAD? Se a resposta for SIM [ABRIR LISTA DE ACHADOS PREDITIVOS DE VAD]	O profissional irá preencher o campo
ACHADOS PREDITIVOS DE VAD	SIM	Combobox	O profissional irá preencher o campo
DISPOSITIVOS AVANÇADOS NECESSARIOS PARA INTUBAÇÃO	SIM (SE A RESPOSTA ACIMA FOR SIM)	Combobox/POSSIBILIDADE DE SELECIONAR MAIS QUE UMA DAS OPÇÕES] [+]	O profissional irá preencher o campo
JEJUM	SIM	Combobox	O profissional irá preencher o campo
PROTOCOLO DE JEJUM PROLONGADO	SIM	Combobox E CAMPO HORA PARA 1°___:_____2°:_____:_____	O profissional irá preencher o campo
LOCAL DE RECUPERAÇÃO	SIM	Combobox	O profissional irá preencher o campo

JUSTIFICATIVA	SIM SE HOUVER INDICAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EM UTI	Caixa de texto	O profissional irá preencher o campo
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O INTRAOPERATÓRIO E OBSERVAÇÕES	SIM	Caixa de texto	O profissional irá preencher o campo